

PARACÉTAMOL (OU ACÉTAMINOPHÈNE)

Mode d'action

Le mode d'action antipyrétique et analgésique du paracétamol n'est pas établi avec certitude. Il franchit la barrière hémato-encéphalique. Son mode d'action n'est pas encore clairement défini, les hypothèses sont :

- une inhibition des cyclo-oxygénases (COX-1, COX-2, COX-3 ? dans le SNC)
- une activation des voies descendantes inhibitrices sérotoninergiques
- une activation du système cannabinoïde (récepteurs CB1)
- une interaction avec le système opioïdergique

Indications

Traitement des douleurs légères à modérément fortes (douleurs aiguës NNT=4 pour 1g de paracétamol)
Traitement symptomatique de la fièvre

Caractéristiques pharmacocinétiques

Aux doses thérapeutiques le paracétamol est principalement glucurono/sulfono-conjugué, seule une faible fraction est oxydée par les CYP 2E1 (1A2, 3A4) en un métabolite hépatotoxique, qui est éliminé après conjugaison au glutathion.

$t_{1/2}$: 2h

Effets indésirables type A

Le paracétamol est bien toléré aux doses recommandées et lors d'emploi de courte durée (< 10 jours)

Hépatotoxicité lors de saturation des voies de glucuronidation et de sulfation conduisant à une production accrue du métabolite toxique et/ou un épuisement des réserves de glutathion qui survient lors

- surdosage intentionnel ou accidentel (cave prises simultanées de préparations contenant du paracétamol)
- jeûne ou dénutrition,
- abus chronique d'alcool
- prise concomitante d'inducteurs des CYP (antituberculeux)
- hépatopathies aiguës ou chroniques

Contre-indications formelles

Troubles sévères de la fonction hépatique/hépatite aiguë;

Troubles sévères de la fonction rénale;

Hyperbilirubinémie constitutionnelle héréditaire (maladie de Gilbert).

Interactions médicamenteuses

Interactions cinétiques

Risque de toxicité hépatique augmenté avec les médicaments inducteurs des cytochromes (rifampicine, carbamazépine)

Interactions dynamiques

tropisetron, granisetron (antiémétiques, antagoniste des récepteurs 5-HT₃)

Pour la pratique

Une intoxication est une urgence médicale. Une toxicité hépatique sévère peut être suspectée si les concentrations plasmatiques de paracétamol sont plus élevées que 300 µg/ml 4 heures ou 45 µg/ml 15 heures après l'ingestion.

Dans les heures qui suivent l'intoxication, une anorexie, des nausées et vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales et sueurs peuvent apparaître, mais le plus souvent il n'y a aucun symptôme signalant la survenue d'une nécrose hépatique. Une augmentation des transaminases, de la bilirubinémie et diminution du taux de prothrombine (Quick) surviennent dans les 12 à 48 heures après un surdosage.

Dans les 4 heures suivant l'intoxication, du charbon activé peut être administré, il diminue l'absorption du paracétamol de 50% à 90%.

La N-Acétylcystéine (NAC) devrait être administrée le plus rapidement possible pour prévenir ou/et traiter la toxicité hépatique du paracétamol. Dans les cas de forte suspicion d'intoxication, elle doit être administrée sans attendre le résultat du dosage plasmatique du paracétamol. Son action dans le mécanisme de détoxification du paracétamol s'explique par son rôle de précurseur du glutathion, ainsi que dans certains cas par ses propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires.

Une dose orale de charge de 140 mg/kg suivie par une administration de 70 mg/kg toutes les 4 heures sont recommandées jusqu'à 17 fois..

Par voie intraveineuse la dose de charge est de 150 mg/kg dans 100 ml de glucose 5% à administrer en 15 minutes (si le patient pèse moins de 20kg), suivie par 50 mg/kg dans 250 ml de glucose 5% sur 4 heures puis 100mg/kg dans 500 ml de glucose 5% sur 16 heures.

Recommander aux patients de lire la composition des médicaments (surtout ceux consommés sans prescription contre les refroidissements, pour éviter la consommation de plusieurs préparations contenant du paracétamol.